

DPOC · exacerbação aguda

Exacerbação de DPOC = piora aguda de dispneia, tosse ou escarro. Trate broncoespasmo e inflamação; reserve antibiótico para critérios de Anthonisen ou pneumonia.

Antibiótico — quando

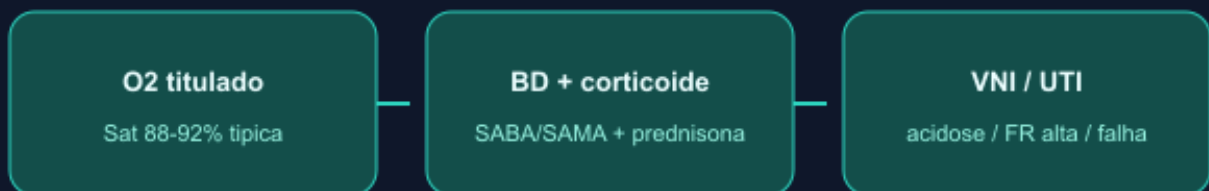
Dica - Antibiótico — quando

Indique se "e 2 critérios de Anthonisen (!'dispneia, !'volume, !'purulência do escarro), especialmente com escarro purulento, ou se houver pneumonia / ventilação mecânica.

Fluxo clássico: oxigenar com alvo !' broncodilatar + corticoide !' decidir VNI/UTI.

Exacerbacao de DPOC

Da porta a decisao de suporte



Tratamento farmacológico

- Broncodilatadores de curta ação: SABA ± SAMA em nebulização/inalação seriada
- Corticoide sistêmico curto (ex.: prednisona 40 mg/dia por ~5 dias) — evita curso longo
- ATB empírico conforme gravidade/Pseudomonas de risco (hospitalizações, DPOC grave)
- Suspende sedativos e corrige precipitantes (IC, embolia, pneumotórax)

VNI — indicações clássicas

Critério | Alvo / nota

Acidose respiratória | pH ~7,25–7,35 com hipercapnia

Dispneia intensa / FR alta | Fadiga muscular iminente

Contraindicações | PCR, vômitos, instabilidade grave, via aérea insegura

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não oxigene 'a 100% sem alvo' no DPOC hipercápnico crônico. Titule SatO₂ , ~88–92% e reavalie gasometria — hipóxia mata, mas hiperóxia pode piorar hipercapnia.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

GOLD/mMRC e critérios de hospitalização definem gravidade e onde tratar a exacerbação de DPOC.

Componente sintomático do GOLD ABE (junto com CAT).

mMRC (dispneia)

0 a 4

0 - so em exercicio intenso	0
1 - ao andar depressa / ladeira	1
2 - anda mais devagar que pares	2
3 - para apos ~100 m	3
4 - nao sai de casa / ao vestir	4

mMRC $\geq$ 2 = mais sintomatico

Marcar gravidade: falência respiratória, comorbidades, suporte social.

Hospitalizar exacerbação?

Critérios de prova

- 1 Dispneia intensa / cianose / confusão
- 2 Hipoxemia grave / hipercapnia / acidose
- 3 Falha de tratamento ambulatorial
- 4 Comorbidades importantes (IC, arritmia)
- 5 Suporte domiciliar inadequado

VNI se acidose respiratoria / trabalho ventilatorio

GOLD — ideia

Lembre - GOLD — ideia

Diagnóstico: VEF1/CVF < 0,7 pós-broncodilatador. Gravidade espirométrica por VEF1 (%): GOLD 1 $\geq$ 80, 2 50–79, 3 30–49, 4 < 30. Grupos A/B/E por sintomas e exacerbações ("e2 moderadas ou "e1 com hospitalização !' E).

Exacerbação — tratamento base

Item | Conduta

Broncodilatador | SABA $\pm$ SAMA nebulizado/inalado

Corticoide | Prednisona ~40 mg/d $\times$ 5 dias (típico)

Antibiótico | se escarro purulento / critérios Anthonisen / ventilação

O2 | alvo SpO2 88–92% (retenção de CO2)

Anthonisen (indicação de ATB)

- Aumento da dispneia
- Aumento do volume do escarro
- Aumento da purulência do escarro
- ATB se 2–3 critérios (purulência tem peso) ou se VNI/IOT

Manutenção

Dica - Manutenção

LAMA/LABA ± ICS se eosinófilos altos/exacerbações; vacinas; cessação do tabaco; reabilitação pulmonar.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1